

29 - 03- LES DÉTRESSES RESPIRATOIRES NÉONATALES - Pr. MAOULAININE

(0:00 - 0:15)

Chers étudiants, bonjour. Dans le contexte COVID, on va voir aujourd'hui notre deuxième corps de neonatologie pour cette année universitaire. On va voir la détresse respiratoire neonatale.

(0:15 - 0:56)

C'est un motif de consultation important et qui nécessite l'hospitalisation dans la majorité des cas. Nous allons voir en suivant une introduction avec une définition de la détresse respiratoire chez nouveau-né, comment on doit faire le diagnostic positif, comment nous devons faire le diagnostic de gravité, qu'il a conduit à devenir en urgence et quels sont les diagnostics étiologiques à chercher. Le diagnostic de gravité, on a dit qu'il faut faire le diagnostic de gravité, il est basé sur ces paramètres.

(0:56 - 1:22)

Le premier, c'est qu'il y a une cyanose qui est rebelle à l'oxygénothérapie, malgré une effluvité supérieure à 100%. Si on a une bradypnée qui est persistante moins de 20 cycles par minute ou bien une tachypnée qui est supérieure à 100 cycles par minute. S'il y a des signes d'épuisement, ça veut dire qu'un nouveau-né va l'utiliser et puis il va se fatiguer.

(1:22 - 2:11)

À un moment donné, le tirage sous constate était important puis une fréquence qui commence à être faible avec une pression qui devient modérée mais le plus souvent, c'est un nouveau-né qui a épuisé ses réserves en calories et il va se fatiguer. Il y a l'acide lactique qui s'installe et on va dire qu'il y a une amélioration du signe alors qu'au contraire, c'est une aggravation du signe parce qu'il est facile. Le temps de recoloration du conjonctif qui est supérieur à 3 secondes, on va palper le talon du nouveau-né pour calculer le temps de recoloration du conjonctif.

(2:12 - 2:47)

S'il y a des signes neurologiques, des convulsions, une hypothèse généralisée, des mouvements anormaux, un pédalage, ce sont des signes neurologiques qui témoignent de la gravité de la détresse respiratoire. On a dit en introduction que le risque majeur c'est l'anoxie cérébrale et parfois malheureusement, ce sont des signes neurologiques qui vont s'installer après les signes de détresse respiratoire et qui vont témoigner de la gravité de la détresse respiratoire. Si on a une potention artérielle, c'est un signe de gravité.

(2:49 - 4:55)

Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence ? Il faut bien placer le nouveau-né sur une table chauffante, il faut libérer les voies aériennes supérieures, on a dit qu'il faut aspirer avec une bouche qui est ouverte, aspirer d'abord la bouche, aspirer le nez, il faut arrêter l'alimentation entière, il faut mettre une sonde gastrique en place, il faut prendre une voie veineuse périphérique ou ombilicale parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie, on a dit que le nouveau-né va se fatiguer, il faut parfois le perfuser par le sérum glucosé, il faut adapter les besoins de l'oxygène en fonction des indications, tout en sachant qu'on commence des besoins à 21%, parfois on peut faire une ventilation par masque s'il n'y a pas de contre-indication, la contre-indication majeure c'est le tolérance du nouveau-né, de la copolymathie, et transitoire c'est l'inhalation méconniale qu'on a expliqué dans le cours de l'alimentation du nouveau-né à la salle de licence, l'oxygène on peut commencer à 21%, parfois à 40% chez un nouveau-né à terme, à 30% chez un nouveau-né prématuré et les indications d'augmenter c'est au fur et à mesure de l'état du nouveau-né, de la saturation et parfois même de la gazométrie. L'intubation, on a vu les indications dans le cours de réanimation du nouveau-né à la salle de licence, l'intubation, ventilation assistée avec intubation, c'est cas par cas, tout en sachant qu'on privilège maintenant la ventilation non invasive. La chronologie des actes, donc toutes 30 secondes par acte, il faut vérifier l'efficacité, on commence toujours par une simulation tactile avec une aspiration, si tout va bien, c'est bon, sinon parfois ventilation masque avec des besoins d'oxygène qui peuvent être augmentés de 21%, 30% à 40% et parfois au-delà de 40% en fonction des indications.

(4:56 - 8:12)

S'il y a une ventilation à réaliser par le réanimateur, c'est la ventilation non invasive d'abord, s'il n'est pas efficace, à ce moment-là, il faut intuber, faire une ventilation invasive, ça veut dire intubation eurotracheale ou bien nasotracheale avec une ventilation par masque et parfois ventilation par un respirateur. Le massage cardiaque plus ventilation, il est rarement indiqué, les choses peuvent rentrer dans l'ordre dans 98% des cas et de moins de 1% qu'on aura besoin d'une administration d'adrénaline avec massage cardiaque, etc. Bien sûr, il ne faut pas oublier la réanimation métabolique, le risque d'hyperglycémie est très important, si pour cela, il faut prendre la voie veilleuse, il faut administrer de sérum glycosée 5% à 10% en fonction des indications.

On voit sur ce diapo deux nouveaux nids qui sont en détresse respiratoire à cause d'une malformation, ce sont deux nouveaux nids, c'est à moi, malheureusement, qui ont décédé. Quelle est la conduite en urgence? Bien sûr, il faut faire les gestes, mais il faut monitorer, ça veut dire prendre les mensurations, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation, il faut adapter la fraction inspiratoire d'oxygène en fonction des indications, il faut prendre la saturation et réaliser parfois même une gazométrie, il faut prendre la tension artérielle, il faut noter les signes cliniques qui doivent être rédigés sur une feuille de surveillance, il faut évaluer d'une manière régulière la fréquence respiratoire, l'intensité des signes de lutte respiratoire, ça veut dire le secours de Silverman, attention s'il y a un nouveau nid qui se fatigue, on va dire qu'il y a une amélioration alors qu'il y a une aggravation. S'il y a des signes neurologiques, c'est un facteur de

mauvais pronostic, c'est un facteur de gravité.

Bien sûr, il faut contrôler la glycémie, éviter l'héopoglycémie qui est délétère pour le cerveau et il faut parfois faire une gazométrie avec une pression artérielle d'oxygène, pression de CO₂ pour pouvoir compter s'il faut augmenter les besoins en oxygène. La conduite en urgence, c'est en fonction du secours de Silverman et en fonction aussi de la fraction inspiratoire d'oxygène, en fonction, est-ce que c'est un nouveau nid qui est prématuré, est-ce que c'est un nouveau nid qui est à terme, est-ce que c'est un nouveau nid qui est épotrophe, est-ce que c'est un nouveau nid macrosome mais d'une manière générale, on va voir si on a un Silverman, un secours de Silverman qui est inférieur à 4 et une fraction d'oxygène qui est à 21%, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ventiler nid par masque si on dit que c'est une détresse respiratoire qui est minime. Une détresse respiratoire modérée, elle est définie par un secours de Silverman qui est entre 4 à 6 avec des besoins qui peuvent aller jusqu'à 40%.

(8:12 - 9:27)

Et chez un nouveau nid qui est une détresse respiratoire sévère, le secours de Silverman est inférieur à 60, la fraction inspiratoire d'oxygène est inférieure à 40%, le secours de Silverman est inférieur à 6, la fraction inspiratoire d'oxygène est inférieure à 40%, il y a des troubles hémodynamiques avec des signes d'épuisement, parfois des signes neurologiques, on dit que c'est une détresse respiratoire sévère. Là, donc, il faut essayer de ventiler d'une manière avec une ventilation non invasive. Si tout va bien, c'est bon.

Sinon, parfois, c'est une indication à l'intubation avec intubation oro-thraquéale ou naso-thraquéale. Ça veut dire qu'on met une sonde à travers le nez dans la trachée et on va ventiler au masque et puis on va passer à un respirateur parce qu'on ne peut pas tenir. Donc vous voyez que s'il y a une détresse qui est modérée, c'est plus souvent une ventilation non invasive, c'est la CPAP, c'est ventilation à pression expiratoire positive et les choses peuvent rentrer dans l'ordre.

(9:30 - 9:57)

Ça, c'est la manière avec laquelle on doit prendre un ballonnet, le masque doit entrer sur la bouche, le nez, du nouveau ballonnet et la bouche doit être ouverte. La position correcte, on a expliqué ça pour que l'air coule bien entre l'oro-thraquéale et la trachée. Donc une position intermédiaire, pas en hyperflexion ni en hyperextension.

(9:59 - 10:23)

Parfois, on est obligé d'intuber, donc s'il y a une détresse qui est sévère, avec le CO₂ qui est supérieur à 40%, avec des signes neurologiques, avec des signes d'épuisement. L'intubation naso-thraquienne, il y a la sonde qui est passée par le nez. Il y a une lame avec un laryngoscope et pince de magie pour intuber un nouveau nez.

(10:24 - 10:32)

Parfois, on peut intuber par la bouche. Le matériel doit être préparé. Vous voyez, pince de magie, laryngoscope et sonde d'intubation.

(10:37 - 11:05)

On a vu le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, qu'en est-il, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de détresse modérée, détresse légère, détresse sévère. Maintenant, on va voir le diagnostic étiologique. Vous voyez que les études ne sont pas en rapport uniquement avec les poumons, elles peuvent être en rapport avec le cœur, avec le cerveau, avec d'autres organes qu'on va voir dans le chapitre des diagnostics étiologiques.

(11:05 - 11:43)

Pour le chapitre des malformations, il y a certaines malformations qui peuvent donner une détresse respiratoire, qui peuvent être responsables d'un kyste bronchogénique, des malformations kystiques pulmonaires conjonctales, un non-physime lobère géant. Ce sont des étiologies rares, mais qui peuvent donner des étiologies pulmonaires, mais il y a d'autres étiologies digestives et cardiaques. Ça, c'est un kyste bronchogénique, un kyste bronchogénique chez un nouveau-né qui est responsable d'une détresse respiratoire.

(11:44 - 12:15)

À gauche, c'est la radio thoracique, et à droite, c'est une courbe de scapula. On peut faire nos diagnostics antinatales d'un kyste bronchogénique par un bon échographiste qui est entraîné avec l'échodexe. Vous voyez les différentes malformations kystiques pulmonaires conjonctales qui peuvent donner une certaine détresse respiratoire chez le nouveau-né.

(12:16 - 12:50)

Malformations kystiques importantes chez un nouveau-né, pour la totalité de l'hémitorax gauche, et refoulant le médiastin vers le côté contrôlateur en rapport avec une malformation kystique pulmonaire conjonctale. Non-physime lobère géant, c'est une étiologie de détresse respiratoire, mais c'est une étiologie. Le diagnostic de certaines malformations congénitales, on a dit qu'il faut faire nos diagnostics à la salle de naissance.

(12:51 - 13:21)

La trépidullosophie doit être faite à la salle de naissance. Parfois, s'il y a un retard de diagnostic, l'épaisse salivation peut orienter devant toute épaisse salivation, mais il faut toujours faire les preuves à la salle de naissance. Il faut donc mettre une sonde par la bouche ou par le nez et vérifier si on entend l'air qu'on injecte dans cette sonde au niveau épigastrique.

(13:21 - 13:52)

Si on n'entend pas ça, il faut faire une radiothoracique et le diagnostic peut être fait rapidement à la salle de naissance. Après, une radiothoracique va montrer la sonde qui est enrôlée. L'air niveau lacropodiaphragmatique le plus souvent gauche est expliqué par la migration des ondes intestinales au niveau thoracique à travers une ernie au niveau du lacropodiaphragmatique le plus souvent gauche.

(13:55 - 14:30)

Il y a des intestins qui vont migrer dans la cavité thoracique et qui vont comprimer le poumon gauche le plus souvent. Après la naissance, il n'y a pas d'air qui va passer dans ce poumon et au contraire, il y a l'air qui passe dans les ondes intestinales et qui va comprimer ce poumon. Il va même divier le cœur vers le côté posé le plus souvent à droite et il va être responsable d'une détresse respiratoire à niveau natal.

(14:31 - 14:58)

On a dit que l'ernie diaphragmatique peut être diagnostiquée en antinatal avec une hypographie. S'il y a un diagnostic antinatal, il faut intuber à la salle de naissance systématiquement avec une bonne ventilation parce que le pronostic de la prise en charge de l'ernie dépend de la précocité du diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait rapidement à la salle de naissance, on aura un bon pronostic.

(14:58 - 15:35)

Au contraire, si on a un retard de diagnostic, la mortalité et la morbidité post-opératoire de la prise en charge de l'ernie diaphragmatique sont importantes. Si on ausculte, les bruits du cœur sont divisés à droite et on voit ausculter parfois au niveau de l'hémitoraxe gauche des bruits hydroaériques en rapport avec l'air qui passe dans les intestins. Donc le diagnostic est facile cliniquement et parfois on aura besoin de réaliser une radiothoracique qui permet de confirmer le diagnostic.

(15:37 - 16:04)

Ici, dans cette diapo, on voit qu'il y a quand même deux choses. La première, on ne voit pas la sonde gastrique au niveau de l'estomac. Deuxième élément, on voit qu'il y a quand même une diminution de la transparence pulmonaire.

(16:04 - 16:30)

On a un foyer lobaire supérieur droit témoignant d'une probabilité d'atteinte de l'obstruction de l'estomac. En rapport avec l'hypersalivation, il y a un enrôlement de la sonde gastrique. C'est une atrésie de l'œsophage.

(16:30 - 16:48)

Vous voyez, les fliches vont vous mentionner l'enrôlement de la sonde gastrique nasogastrique-mélinaso. Au niveau de l'estomac, il n'y a pas de bout distal de la sonde. Malheureusement, il y a une atteinte du parenchyme pulmonaire.

(16:49 - 17:15)

C'est un diagnostic qui a été fait tardivement chez un nouveau-né HG4. Ici, on a dit que, si on l'interprète, premièrement, la sonde qui est en place, on voit que la sonde met, il y a la sonde qui est déviée à droite. Il y a le cœur qui est dévié à droite.

(17:16 - 17:44)

On voit dans le poumon gauche qu'il y a des niveaux, donc des anses pleines d'air avec une compression. On ne voit pas le poumon gauche et le cœur, l'œsophage, ils sont déviés à droite. C'est un diagnostic d'une diaphragmatique importante avec une compression du poumon gauche.

(17:46 - 18:06)

Ici, on voit qu'il y a quand même une diminution de la transparence. La sonde gastrique, c'est très important de vérifier que la sonde gastrique est en place. Il y a une hyperaération à gauche et à droite.

(18:06 - 18:36)

On ne voit pas d'air parce que c'est un peu manqué. C'est une agénésie pulmonaire à droite chez un nouveau-né qu'on a diagnostiquée et malheureusement, elle est décédée quelques jours après ce diagnostic. Sur cette copie scanographique, il n'y a pas de poumon à droite et le cœur est dévié.

(18:37 - 19:00)

Il y a donc la trachée et il y a une seule branche source gauche. Ici, on voit que c'est un nouveau-né qui a été intubé et que l'estomac n'est pas à gauche, c'est à droite. Il y a une cardiomygalie.

(19:01 - 19:22)

Il y a l'extracardie avec CAV et CIV et un situs inversus. Vous voyez qu'il y a plusieurs malformations. On commence toujours par les malformations qui peuvent donner une détresse respiratoire.

(19:22 - 19:47)

Il y a les malformations pulmonaires, l'emphysème, les malformations kystiques, mais il y a aussi les malformations digestives. Le plus souvent, c'est l'hérénie de la copomodifrite qui fait le diagnostic. Il y a aussi les malformations cardiaques qui peuvent donner une détresse respiratoire.

(19:48 - 20:11)

D'autres malformations, il y a le syndrome de Pierre-Robin avec une hypoplasie mandibulaire, un rétrogonatisme, une fente palatine et une glossoptose. Il y a aussi la trisomie 21 qui faut diagnostiquer à la salle de naissance. On va placer une sonde gastrique qui ne peut pas franchir le nez.

(20:11 - 20:33)

Parfois, les coanes peuvent être membranées ou bien osseuses. On doit réaliser une TTM pour confirmer le diagnostic. Quelle est l'étiologie la plus fréquente ? Les sujets les plus fréquents de détresse respiratoire chez le nouveau-né dans notre contexte ce sont les infections.

(20:33 - 20:48)

C'est-à-dire les infections bactériennes précoces. On va voir le cours des infections bactériennes chez le nouveau-né la semaine prochaine. C'est une étiologie fréquente de détresse respiratoire.

(20:49 - 21:22)

Pour cela, il faut faire une anamnèse qui doit être bien conduite. S'il y a une infection périnatale, s'il y a une fièvre maternelle séparée à 38 pendant l'accouchement, dans les 48 précédant l'accouchement ou bien dans les 6 ans qui suivent l'accouchement. Est-ce qu'il y a une rupture primordiale du membre à 12 heures ? Est-ce qu'il y a un travail prolongé ? Est-ce qu'il y a une souffrance vitale sans cause obstétrique ? La définition de souffrance vitale est une définition qui est anamnistique clinique.

(21:23 - 21:51)

Sans cause obstétrique, ça veut dire qu'il y a une bradycardie vitale, qu'il y a le liquide qui devient biconique et il y a un virage avant la naissance. Et après la naissance, il y a un secours d'upgrade qui est inférieur à 5 minutes après la naissance. Donc il persiste à moins de 5 après 5 minutes de la naissance, parfois même à des minutes inférieures à 5 avec parfois des signes neurologiques importants, des convulsions, etc.

(21:53 - 22:14)

S'il y a une prématurité inexpliquée, c'est en faveur d'une infection jusqu'à preuve du contraire. Donc la prématurité inexpliquée, s'il y a une grossesse jumellaire, s'il y a un traumatisme, s'il y a

une maman qui est hypertendue, s'il y a une prééclampsie. La prééclampsie, ça veut dire qu'il y a une atteinte rénale secondaire à une hypertension maternelle.

(22:15 - 22:36)

Donc c'est un cours que vous allez voir en 5e année. Pour ne pas détailler tous les signes de l'infection, il y a des critères anamnistiques, des critères cliniques et des critères paracliniques. Plus souvent la radiothoracique qui peut montrer des opacités de type alvéolaire qui peuvent être diffuses, qui peuvent être localisées.

(22:36 - 23:00)

Avec une numération sanguine en faveur d'une infection, avec un dosage de la CRP en faveur d'une infection bactérienne précoce. L'inhalation du liquide amniotique méconial et du liquide amniotique clair. On a dit que le méconium c'est le premier sel du nouveau-né.

(23:00 - 38:05)

Parfois le nouveau-né va faire ses sels dans le ventre de sa maman et à cause d'une mauvaise perfusion et donc le sphinctre anal va s'ouvrir et les sels vont se diversifier dans la cavité amniotique et le liquide amniotique clair au début va devenir un liquide qui est verdâtre et le nouveau-né, le fœtus, va inhaler et le liquide amniotique s'est inhalé par le fœtus après sa naissance et il va y avoir une détresse respiratoire secondaire à certaines obstructions parce que le méconium c'est une substance qui est gélatineuse, qui est collante et donc il va y avoir un retentissement sur le surfactant il peut détruire le surfactant il peut donc fermer certains bronchioles et donc donner soit un lymphœdème ou bien une atelectasie en fonction de la vitesse qu'il va fermer ce bronchiole. Parfois le fœtus peut inhaler le liquide amniotique qui est clair et c'est une détresse respiratoire qui est précoce et qui nécessite une prise en charge rapide. En cas d'inhalation méconiale on a déjà expliqué ça, on a dit que si le nouveau-né il a crié, il faut juste aspirer bien sûr après avoir dégagé les épaules et on a fait une aspiration au carrefour de l'oropharynx si le nouveau-né n'a pas crié c'est une indication, une intubation on va intuber, on va aspirer et après on va ventiler donc il faut intuber avec une bande avec une sonde nasotrachéale ou endotrachéale il faut aspirer et puis il faut ventiler donc on ne ventile pas en premier lieu en cas d'une détresse respiratoire secondaire à une inhalation méconiale nous devons aspirer si le nouveau-né l'a crié, nous devons aspirer et puis ventiler si le nouveau-né n'a pas crié, il faut intuber aspirer et puis ventiler. Une autre idéologie des détresses respiratoires l'inonotaxie et l'encéphalopathie anoxiques chimiques elle est définie par des critères qui sont anamnistiques, on a dit une anomalie du rythme cardiaque fatale, une bradycardie fatale, moins de 100 battements par minute un rythme cardiaque fatale qui est plat donc il n'y a pas de variation une anomalie du rythme avec des décélérations qui sont tardives ce sont une bradycardie une bradycardie fatale ou bien une tachycardie qui sépare à 180, 170 signes du rythme cardiaque qui peuvent orienter vers une encéphalopathie anoxiques chimiques bien sûr la

perte à la licence qui est basse inférieure à 5 après 5 minutes mais parfois après 10 minutes s'il y a des signes convulsions plus pédalage, boxage, révulsion des yeux parfois les boutons généralisés associant des signes cliniques d'une encéphalopathie anoxoïde chimique c'est une agence et par conséquent elle peut donner une détresse respiratoire une autre physiologie c'est la maladie d'Imbricoline qui est définie par un déficit quantitatif ou qualitatif du surfactant le surfactant c'est une substance synthétisée par les pneumocytes en antenatal entre 20 et 22 semaines ça permet aux alvéoles de rester ouvertes et on va voir que la quantité est insuffisante chez le prématuré le plus souvent moins de 28 semaines parfois il est synthétisé mais il est détruit par le surfactant il sera détruit par le myconium ou bien par l'infection parfois le nouveau-né de mère diabétique qui a un déficit quantitatif donc s'il y a manque de quantité s'il y a une restriction, s'il y a la qualité qui n'est pas bonne, le surfactant les alvéoles ne vont pas rester ouvertes il va y avoir une détresse respiratoire secondaire par la qualité ou la quantité insuffisante du surfactant heureusement depuis 20 ans plus que 20 ans maintenant 30 ans la ventilation en pression positive elle a changé le pronostic de prise en charge des détresses respiratoires en rapport avec une maladie de bronchopneumopathie donc là c'est pas pour bien la ventilation le surfactant exogène chez certains nouveaux-nés par exemple à 24 semaines, 26, 28 on peut insérer le surfactant même jusqu'à 32 semaines on peut insérer le surfactant c'est une indication bien sûr après avoir fait le diagnostic un élément très très important et j'insiste sur ces éléments c'est la corticotérapie en antenatal chez la maman parce qu'on donne la vitamitazone donc on donne deux injections à 24 heures d'intervalle en cas de menace d'accouchement prématuré le prématuré on a dit un nouveau-né qui est moins de 37 semaines mais les indications de la corticotérapie c'est aussi le nouveau-né qui vont naître avant 34 semaines ça veut dire s'il y a une menace d'accouchement avant 34 semaines on donne la corticotérapie au-delà de 34 semaines les indications ne sont pas claires mais ce que je demande de retenir c'est que cette corticotérapie on fait une cure avec deux injections de 24 heures d'intervalle en cas de menace d'accouchement prématuré cette corticotérapie va permettre la synthèse du surfactant chez le nouveau-né mais aussi chez le nouveau-né prématuré qui a moins de 34 semaines il va diminuer le risque d'anthrax et sera hémorragique il va aussi diminuer le risque des hémorragies périventriculaires je demande de retenir les effets de la corticotérapie chez le nouveau-né la corticotérapie administrée en antenatal en cas de menace d'accouchement prématuré et c'est une corticotérapie à base de bétaméthazone on voit ici des pommes opaques les deux pommes si on compare avec la clarté la clarté digestive ici il y a la poche érogastrique qui est claire et les pommes sont blanches il n'y a pas d'air qui passe dans les alvéoles parce qu'il n'y a pas de surfactant et les alvéoles sont presque fermées dans la majorité des cas on insère bien sûr le surfactant maintenant il y a plusieurs méthodes soit on va intuber ou insérer ou bien parfois on va mettre juste une sonde et insérer le surfactant ça c'est le cercle vicieux de la maladie parce qu'il n'y a pas de surfactant il va y avoir une atelectasie avec une hypoventilation une acidose avec une hypercapnée il va y avoir une hypotension avec vasoconstriction, hypoperfusion et diminution du métabolisme cellulaire de base et une épovolémie pour vous dire qu'il faut insérer ou bien le surfactant en urgence si on fait le diagnostic ou bien mettre le nouveau-né sous

ventilation non invasive et puis insérer le surfactant la méthode c'est un nouveau-né qu'on a intubé qu'on a administré maintenant il y a une autre méthode qu'on peut administrer sans intuber le nouveau-né on va mettre une sonde directement au niveau de la trachée sans intubation de la zone trachée donc on voit dans cette radio qu'il y a une cardiomygalie et puis il y a une déviation du coeur mais on va voir qu'il y a une diminution de la transparence à gauche avec une lame et une ligne bordante témoignant d'un épanchement pleural à gauche c'est un chialotorax parmi les utilisations du test respiratoire et il y a les épanchements de la plèvre qu'il soit un gaz, un pneumothorax ou bien une pleurisie parfois à la chialotorax c'est un diagnostic rare mais c'est un diagnostic que nous devons le faire donc on voit ici qu'il y a quand même un pneumothorax avec une déviation du coeur vers le côté à gauche donc pleurisie, chialotorax pneumothorax c'est l'usage des traces respiratoires à niveau natal, quoi qu'ils soient rares mais il faut toujours éliminer le nouveau-né qui avait un chialotorax qu'on a traité donc vous voyez la radio après 3 mois une autre étiologie des détresses respiratoires à niveau natal, c'est une étiologie d'élimination ça veut dire une détresse respiratoire transitoire c'est une anomalie de la résorption de liquide pulmonaire ce sont les nouveaux-nés nés par césarien qui présentent cette détresse respiratoire parfois il y a un nouveau-né qui s'en est par voie basse mais l'accouchement était tellement rapide qu'il n'y avait pas de compression de thorax donc le pulmon n'a pas pu être résorbé mais c'est moins de 2h donc moins de 2h le plus souvent au-delà de 2h c'est plus une détresse respiratoire transitoire il faut faire le diagnostic d'une autre étiologie donc radio-thoracique, surveillance et les choses peuvent rentrer dans l'ordre avec des petites mesures d'orientation d'autres étiologies des détresses respiratoires il y a le problème métabolique l'hypoglycémie et l'hypocalcémie on a dit qu'il y a des nouveaux-nés qui ont un risque d'hypoglycémie donc il y a le nouveau-né prématuré il y a le nouveau-né qui a une détresse respiratoire il y a le nouveau-né qui a une encéphalopathie anoxysquémique il y a le nouveau-né qui est de mère diabétique ce sont des nouveaux-nés qui peuvent présenter un risque d'hypoglycémie et ils peuvent présenter des détresses respiratoires donc il faut étiqueter et détecter ce type d'hypoglycémie s'il y a un porteur de risque et il faut la corriger rapidement avec un apport soit alimentation entérale soit prendre une voie veineuse et corriger rapidement l'hypocalcémie est une étiologie des détresses respiratoires certains nouveaux-nés peuvent présenter une hypocalcémie il faut faire le diagnostic rapidement il y a certaines affections neuromusculaires mais c'est très très simple en conclusion la détresse respiratoire est un syndrome ce n'est pas une maladie donc il faut faire le diagnostic qui est basé sur des critiques qui sont cliniques anomalies de la respiration, l'existence de la cyanose et l'existence des signes de détresse respiratoire il faut que là si c'est une détresse respiratoire qui est légère, qui est modérée, qui est sévère il faut faire des soins en urgence des gestes en urgence, en libérant les voies aériennes en aspirant il faut ventiler il faut ventiler une indication par ballonnée ou par une ventilation non invasive s'il n'y a pas d'amélioration il faut intuber et surveiller au fur et à mesure les autres paramètres la fréquence cardiaque, la saturation la température, la glycémie les signes neurologiques etc il faut détecter les signes de gravité d'une détresse respiratoire des convulsions, une hypotension une mauvaise perfusion périphérique tout ça on l'a expliqué au

cours mais ce qui est important, il faut faire le diagnostic parfois de certaines études en antenatal certaines malformations qui peuvent être diagnostiquées en antenatal il faut faire le diagnostic à la salle de naissance l'atrésie de l'œsophage, l'atrésie du couroir l'absence de l'acropole diaphragmatique elle doit être diagnostiquée à la salle de naissance pour prendre en charge correctement le nouveau-né s'il y a une menace d'accouchement prématuré moins de 34 semaines, la cortico-thérapie à la base de betaméthasone doit être administrée à la maman parce qu'elle va permettre un bon développement une synthèse de surfactant chez le nouveau-né mais aussi une diminution de risque d'entérococolite hémorragique donc entérococolite hémorragique c'est une pathologie spécifique du prématuré et il va y avoir aussi une diminution de risque de leucomalacie périventriculaire donc pour prévenir la maladie d'Embryomyelination il faut administrer la cortico-thérapie chez la maman en cas de menace d'accouchement prématuré moins de 34 semaines. Le pronostic dépend de la qualité mais aussi de la précocité de diagnostic et de la qualité d'une prise en charge qui doit être adaptée en fonction de chaque étiologie tout en respectant, tout en essayant d'éviter l'anoxie cérébrale.

(38:05 - 38:08)

Je vous remercie, chers étudiants.